Psicopatología de la audición y el lenguaje

Unidad 1. Hacia el conocimiento de la psicopatología de la audición y el lenguaje

ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE 1

INTRODUCCIÓN 2

ABORDAJE Y CATEGORIZACIÓN DEL CONCEPTO DE PSICOPATOLOGÍA 3

Sección 2.1 El concepto de psicopatología: etimología y actualidad 3

Sección 2.2 La psicopatología infantil: aparición, principios y fundamentos 3

Sección 2.3 La psicopatología infantil: dificultades en su estudio y categorización 4

Sección 2.4 Psicopatología: modelos y niveles 5

PSICOPATOLOGÍA EN EL CAMPO DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE 7

Sección 3.1 Introducción: objetivo de estudio y modelos teóricos 7

Sección 3.2 Modelo médico: análisis y abordaje de ámbitos 8

Sección 3.3 Modelo conductual o educativo: análisis y abordaje de ámbitos 9

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE 11

Sección 4.1 Introducción 11

Sección 4.1 Equivalencias entre el DSM-V y la CIE-11 12

PSICOPATOLOGÍA DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE EN EL MARCO EDUCATIVO DE LA LOMLOE 15

RESUMEN DEL TEMA 17

GLOSARIO 19

BIBLIOGRAFÍA 21

INTRODUCCIÓN

La psicopatología del lenguaje y la audición se ocupa del estudio de los trastornos, alteraciones o desórdenes del lenguaje manifestados a través de la voz, el habla, la comunicación, las funciones orofaciales y también de la audición (. Estas perturbaciones pueden implicar a todos o algunos de los componentes del sistema lingüístico (fonológico, morfológico, sintáctico, semántico o pragmático) y su manifestación puede estar causada o influenciada por factores sociales, psicológicos y biológicos.

Tomando como referencia lo anterior, en esta primera unidad se va a repasar la evolución del concepto de psicopatología del lenguaje partiendo de la psicopatología en general, hasta conseguir poner el foco en la psicopatología de la audición y del lenguaje en la población infantil. Asimismo, se trabajarán algunos de los sistemas de clasificación que existen para poder llevar a cabo un enmarque centralizado de las distintas patologías que existen dentro del sistema educativo español.

ABORDAJE Y CATEGORIZACIÓN DEL CONCEPTO DE PSICOPATOLOGÍA

Sección 2.1 El concepto de psicopatología: etimología y actualidad

Cuando se hace referencia al término *psicopatología*, lo primero que se debe tener en cuenta es su objetivo tradicional: *establecer grupos de manifestaciones de la conducta para explicar las causas, investigar y definir fórmulas de intervención.*

Según el diccionario de Porot, la psicopatología, etimológicamente estudio de las dolencias del alma, puede definirse como una ciencia que toma su objeto de la psiquiatría y su espíritu de la psicología.

Así, es la fundamentación científica de la psiquiatría, para lo cual precisa delimitar conceptos generales con validez universal en el campo de la patología. Su centro de interés es el estudio de la conducta alterada o de las alteraciones conductuales del sujeto. Dicho estudio científico, supone la descripción, la explicación y la clasificación de esa conducta y de las variables responsables de las alteraciones conductuales que se producen durante el período infantil, adolescente o adulto.

Sección 2.2 La psicopatología infantil: aparición, principios y fundamentos

La psicopatología surge en el siglo XX. Al principio, solo estudiaban los trastornos que se daban en la población adulta, mientras que la población infantil no se tenía en consideración al pensar que esta no era susceptible de padecer trastornos mentales. Su evolución ha seguido un curso cíclico que ha dependido de las teorías que han ido marcando la psicopatología general y de las actitudes sociales hacia la infancia.

Así, queda claro que el interés por clasificar las enfermedades de los niños es, sin duda, un fenómeno reciente y que, por tanto, su aparición es posterior al desarrollo de las clasificaciones del adulto. De este modo, la clasificación de la psicopatología infantil sigue siendo todavía muy dependiente de la nosografía pensada para el adulto, etapa en la que los síndromes y trastornos suelen estar mucho más delimitados y fijos que en el adolescente o en el niño. Esto hace que en este último decenio del siglo XX todavía queden muchas cuestiones por resolver en la forma de clasificarla.

Tradicionalmente, se ha basado principalmente en la clínica y ha vivido hasta hace pocos años casi al margen de las clasificaciones, pues hoy todavía existen profesionales que piensan que clasificar los trastornos mentales de los niños y adolescentes es contraproducente. En este sentido, es importante tener en cuenta que, aunque el profesional clínico con experiencia pueda resolver el problema psicopatológico de un niño sin acudir a las clasificaciones, estas son imprescindibles para el progreso científico.

Así, sin unos criterios diagnósticos operativos y un sistema clasificatorio adecuado es imposible, pues elegir un sistema de clasificación en psicopatología infantil es una tarea comprometida y difícil porque cualquier elección no es neutra y viene provista de numerosas dificultades. Sin

embargo, orienta de forma muy decisiva la práctica clínica, el tratamiento o la investigación y ayuda a:

a) realizar buenos estudios epidemiológicos.
b) evaluar resultados de un tratamiento con psicofármacos o con técnicas psicológicas.
c) hacer investigación genética de los trastornos mentales infantiles o contrastar resultados obtenidos por los estudiosos del tema en diferentes laboratorios y hospitales.

Sección 2.3 La psicopatología infantil: dificultades en su estudio y categorización

Como se mencionaba anteriormente, elegir un sistema de clasificación en psicopatología infantil es una tarea comprometida y difícil porque cualquier elección no es neutra y, generalmente, viene acompañada de dificultades asociadas como las que siguen a continuación:

a) Los apartados que tratan de los niños en las dos grandes clasificaciones de mayor difusión internacional, el DSM (APA) y la CIE (OMS), tienen poco en cuenta el factor evolutivo, así como las diferencias de expresión de los síntomas según la edad. Esto constituye un verdadero problema en las primeras etapas del desarrollo.

    - El espacio reservado a los niños en estas dos clasificaciones es proporcionalmente muy reducido. Esto arranca desde el inicio de las clasificaciones categoriales, es decir de la obra de Kraepelin. Cuando éste publicó por primera vez la clasificación de las enfermedades mentales (1899) no dedicó ningún apartado a los niños. Esta laguna se ha ido perpetuando en las clasificaciones posteriores.

b) Una dificultad importante para clasificar los trastornos en la infancia es su delimitación.
    - En psicopatología infantil la tarea de describir y delimitar exactamente los trastornos, condición indispensable para clasificar, está todavía en parte por hacer.
        i. No existe, hoy por hoy, consenso sobre qué trastornos existen realmente en los niños; este problema se acrecienta por debajo de los seis años.
        ii. La comorbilidad es muy elevada tanto en los niños más pequeños como en el adolescente. Esto explica que se cambien o se introduzcan nuevas categorías de una edición a otra dentro de una misma clasificación.
            1. i.e., el DSM-IV introduce el "trastorno de la alimentación en la infancia" que no era contemplado ni por el DSM-III ni por el DSM-III-R y, recientemente, el DSM-5 sustituye el Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) por el concepto de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y quita el lenguaje de sus criterios diagnósticos.

c) Si se comparan las categorías diagnósticas de las tres clasificaciones más utilizadas en Europa, llama la atención la falta de concordancia entre ellas.
    - Los tipos de depresión infantil de estas tres clasificaciones son distintos. Algunas psicopatologías infantiles o juveniles no se pueden englobar en ninguno de los

criterios de una clasificación determinada o, si se hace, es solamente de una forma aproximada.

d) Si en vez de utilizar una clasificación categorial se opta por una clasificación cuantitativa se resuelven algunos de los problemas anteriores, pero se encuentran otros.
    - Esta nueva forma de clasificar no parte directamente de la clínica y los síndromes con escasa prevalencia como es el TEA infantil no quedan reflejados en la clasificación.

Tomando como base lo anterior, el profesional de Audición y Lenguaje se encuentra entre dos extremos: un sistema muy codificado de gran difusión en la comunidad internacional pero rígido y reduccionista por haber tenido que simplificar el contenido psicopatológico, o bien un sistema más flexible que valore más los aspectos evolutivos y de continuidad o discontinuidad de las patologías, a cambio de perder objetividad y operatividad.

Sección 2.4 Psicopatología: modelos y niveles

Para que un comportamiento sea considerado no típico se debe tener en cuenta que sea infrecuente, además de conllevar consecuencias negativas para la propia persona o su entorno. Si además se refiere a la población infantil, se debe tomar en consideración los aspectos evolutivos, la edad, el sexo, su desarrollo cognitivo, la inconsistencia de la conducta infantil y el contexto. En este sentido, el conceptualizar una conducta como no típica dependerá, en mayor medida, del marco teórico y criterios que se seleccionen. Para ello, las principales teorías se organizarían en torno diversos modelos de estudio (véase Tabla 1).

Tabla 1.
Modelos de estudio (Bórnez, 2015)

Modelos	**Objetivos**
Médico	Tiene en cuenta las alteraciones orgánicas y también cómo se estructura a nivel intrapsíquico. Tiene en cuenta las variables que el sujeto manifiesta en esa conducta problema
Psicoanálisis	Considera poco el nivel orgánico. Centra su explicación en la estructura intrapsíquica; cómo el sujeto organiza los trastornos
Humanista	Pone el acento en todos los aspectos que están en las relaciones interpersonales. Como complemento pone la incidencia social
Aprendizaje Social	Hace mayor hincapié en el aspecto interpersonal y la socialización

Los modelos anteriormente descritos han sido integrados en un modelo de psicología infantil denominado *psicología del desarrollo,* la cual se encarga de investigar acerca de los cambios de carácter mental y comportamental que tienen lugar a lo largo de la vida de las personas, es decir,

desde la infancia hasta la vejez, pero, en la práctica pone mucha atención en la infancia y en la adolescencia.

Así, tiene en cuenta tanto los procesos de transformación biológica ocurridos en el organismo con el paso de los años (el más claro es el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso en general), como los cambios de tipo psicosocial (por ejemplo, las diferentes expectativas y roles a ocupar que nos encontramos a medida que crecemos y maduramos), apoyándose en líneas comunes como:

a) El desarrollo se entiende como la adquisición de sucesiones lineales que se observan en la mayoría de un conjunto de población determinada.

b) Esta adquisición de sucesiones se asienta en procesos circulares que están implicados en el paso de una etapa a otra, por lo que, se supone, que si no se adquiere un proceso previo, éste influirá en la adquisición de un proceso de una etapa superior.

c) Estos procesos no son homogéneos, sino que hay alguno que cumplen un grado de evolución, mientras que otros siguen un proceso discontinuo.

Por ello, haciendo hincapié en la psicopatología, lo que interesa conocer es: (I) cuál es el desarrollo de los procesos que predisponen a la aparición de conductas no típicas y de qué forma interactúan en los otros aspectos para comprender la alteración; (II) hasta qué punto una conducta está produciendo retraso en su etapa evolutiva; y (III) cómo intervenir y/o estimular esa conducta para favorecer un desarrollo integral de cada sujeto.

PSICOPATOLOGÍA EN EL CAMPO DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE

Sección 3.1 Introducción: objetivo de estudio y modelos teóricos

Una vez se ha abordado qué es la psicopatología y qué campo de estudio e intervención recoge, es importante concretar su función en torno al campo científico de la audición y el lenguaje.

En este sentido, es importante tener en cuenta que esta rama de la psicopatología se centra en los trastornos de la comunicación y el lenguaje, es decir, patologías que difieren de la norma o que causan desórdenes a nivel lingüístico que pueden implicar a todos o a algunos de los componentes: *fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o pragmático.*

Por ello, se considera necesario empezar por diferenciar qué se entiende por alteración típica y alteración patológica. Para ello, debe tomarse como referencia el nivel de desarrollo esperado en los diferentes ámbitos de la comunicación y el lenguaje (véase Tabla 2).

Tabla 2.
Nivel de desarrollo esperado en los diferentes ámbitos de comunicación y lenguaje (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012)

Niveles	Descripción
Nivel fonológico	Trataría de comprobar que el individuo no sufre ningún daño a nivel anatómico o funcional que le impida hablar o expresarse correctamente (alteración en los órganos que puedan estar relacionados con la alteración del habla).
Nivel social	Se observaría si un sujeto es capaz de interactuar con la mayoría de la gente y si se ajuste al contexto comunicativo y las normas de interacción social propias de la sociedad en la que este sujeto está inserto
Nivel individual	La capacidad de comunicación a través del lenguaje de cada sujeto debe permitir que éste pueda tener un desarrollo apropiado en el contexto en el que vive y pueda participar en los diferentes ámbitos adaptativos de la vida.
Nivel temporal	Valoración de si el trastorno o la dificultad es de tipo periódico (por ejemplo, por maduración o pérdida de los dientes), crónico (imposibilidad de hablar) o degenerativo. Igualmente se incluiría si es temporal o ante ciertos momentos o estímulos (por ejemplo, cuando uno está nervioso) o permanente, en todas las situaciones. Por último, es necesario valorar también si es genético o desde el momento del nacimiento, o bien es sobrevenido por una lesión o enfermedad.

En función de cómo se arbitran todos estos niveles, el análisis de la psicopatología de la audición y lenguaje debe desarrollarse, como ya se vio anteriormente, desde dos modelos básicos:

a) **Modelo médico**. Relacionado con los aspectos biológicos del trastorno (anatomía, neurología...). Según este modelo, se trata de buscar la causa del trastorno del lenguaje,

y posteriormente describir dicho trastorno en función del factor causante. Trata los trastornos como si fueran cualquier otro tipo de enfermedad, aunque no presenta un pronóstico para corregirlo.

b) **Modelo conductual o educativo.** Surge de las ciencias de la conducta, sobre todo de la Lingüística y la Psicología. No se centra en buscar la causa de los trastornos, sino que analiza directamente la conducta lingüística alterada, tratando de buscar patrones que se asemejen a la conducta normal. Estas características que quedan del habla normal ayudan a programar a la intervención o tratamiento que se le va a aplicar al trastorno.

Como especialistas en audición y lenguaje, la intervención se basará en ambos modelos, puesto que en el diagnóstico inicial o en el análisis del informe de evaluación psicopedagógica, necesario para diseñar y programar la intervención, es necesario un modelo médico que detectará los puntos débiles a mejorar y los puntos fuertes sobre los que asentar la intervención educativa. Por su parte, en segundo lugar, el profesional debe apoyarse en un método conductual o educativo para llevar a cabo el desarrollo de cada una de las sesiones.

Sección 3.2 Modelo médico: análisis y abordaje de ámbitos

Dentro del modelo médico existen tres ámbitos que, como profesional de audición y lenguaje, se deben tener en cuenta: sintomatología, etiología y etiopatogenia.

3.2.1. Sintomatología

El modelo médico hace referencia al análisis de la sintomatología del caso, es decir, a las características externas del lenguaje. Dentro de él, a veces, a síntomas y, a veces, a signos: los síntomas hacen una referencia subjetiva a una enfermedad, y los signos, a los aspectos físicos.

- Cuando se presenta un caso de labio leporino, los síntomas serán la dificultad para articular, masticar y realizar la deglución, mientas que los signos serán malformación de los labios y el paladar y maloclusión dental.

Asimismo, dentro de este apartado también se incluirán aspectos cuantitativos como la cantidad de vocabulario y cualitativos, como la calidad del vocabulario, para realizar un juicio al analizar el lenguaje de una persona.

3.2.2. Etiología

Un segundo ámbito básico del modelo médico en la psicopatología de la audición y lenguaje es la etiología, es decir, las causas que provocan la sintomatología observada. En este sentido, desde el campo de estudio que ocupa puede observarse una nómina diversa: Tipo genérico, malformaciones, idiopáticas, origen psicológico, origen inmunológico, origen nutritivo, origen metabólico, neoplásicos, origen biológico, malformaciones congénitcas y lesiones físicas y químicas (Bórnez, 2015).

De este modo, y a modo de resumen, la patología lingüística, podría resumirse en los siguientes ámbitos: causas orgánicas, funcionales, órganicas funcionales, endocrinas y ambientales (véase Tabla 3).

Tabla 3.
Ámbitos de la patología lingüística (Bórnez, 2015)

Causas	Descripción
Orgánicas	Una patología puede estar provocada por una alteración o lesión a nivel orgánico. En el caso del lenguaje, la alteración se puede encontrar en el sistema respiratorio, el sistema auditivo, en la vista, el sistema fono articulatorio o en el sistema nervioso.
Funcionales	Alude al mecanismo fisiológico en los sistemas del habla o del oído, pero sin padecer ninguna lesión, sino una disfunción.
Orgánicas-funcionales	La causa de una patología puede comenzar siendo una alteración de tipo orgánico, y luego de tipo funcional, y viceversa. Dentro de esta categoría se podrían citar ejemplos como: o Disfonías funcionales; por un abuso de la voz se producen molestias. o Disemia orgánica; se produce por una lesión en algún órgano, como en las cuerdas vocales
Endocrinas	Tiene que ver con una alteración interna, sobre todo a nivel hormonal. Una cierta anomalía en la secreción hormonal puede producir alteraciones al nivel del habla y de la voz.
Ambientales	Se refieren al contexto ambiental o cultural, que influyen o no en el aparecimiento de patologías lingüísticas, como retrasos en el desarrollo del lenguaje por falta de estimulación por parte de los familiares.

3.2.3. Etiopatogenia

Por último, y en tercer lugar dentro del modelo médico, dentro de la psicopatología del lenguaje es necesario centrar el discurso en la etiopatogenia, es decir, el curso de las enfermedades y los motivos que condicionaron las causas.

Este ámbito trata de realizar una curva evolutiva del desarrollo de la enfermedad, y si es posible, averiguar qué es lo que ha provocado que en un momento determinado, apareciera este trastorno. Este estudio clínico permite luego al especialista establecer el pronóstico (juicio que establece el especialista acerca del trastorno del paciente; lo que espera que vaya a suceder, con el curso de la enfermedad, con la implementación o no de un determinado tratamiento…).

Sección 3.3 Modelo conductual o educativo: análisis y abordaje de ámbitos

De este modelo se obtendrá información de qué es el lenguaje. Además, ofrece información de la configuración o estructura de este, diferenciándose varios niveles (Bloom y Lahey, 1978; en Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012): fonético, fonológico, morfológico y sintáctico, contenido y uso o pragmático (véase Tabla 4).

Tabla 4.
Niveles de estructuración del lenguaje (Bloom y Lahey, 1978; en Dieguéz-Vide y Peña-Casanova, 2012)

Niveles	Objetivo
Fonético	Centrado en el estudio y estimulación de la producción y percepción de los sonidos a partir de los movimientos del aparato fonador y cavidades de resonancia.
Fonológico	Centrado en la seleccionan y se organizan de fonemas para formar sonidos que configuran palabras.
Morfológico y sintáctico	Se encarga de la forma de combinar las palabras para dar lugar a las oraciones, así como, la estructura interna de las frases y palabras, es decir, el conjunto de elementos y reglas que permiten construir oraciones con sentido y carentes de ambigüedad mediante el marcaje de relaciones gramaticales, concordancias, indexaciones y la estructura jerárquica de constituyentes sintácticos.
Contenido	Hace referencia al significado de las palabras, a la semántica, es decir, al rango de palabras que tiene un sujeto para transmitir el pensamiento o sentimiento que quiere externalizar. De modo concreto sería el léxico o vocabulario del sujeto.
Uso o pragmático	Se encarga de estudiar la utilidad del lenguaje en función del contexto y la necesidad que cada sujeto tiene. Dentro de este nivel se incluyen ámbitos de intervención como las relaciones con los otros, las conversaciones, el respeto de los turnos conversaciones, la elicitación de demandas, la expresión de emociones o sentimiento, la regulación de la conducta propia y/o a de los demás…

En definitiva, teniendo en cuenta todo lo anterior, la labor del especialista en audición y lenguaje en los centros educativos es una labor polivalente que necesita de una formación solida en educación, logopedia, desarrollo evolutivo y desarrollo del lenguaje para poder dar respuestas a las necesidades que se plantean.

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE

Sección 4.1 Introducción

El lenguaje es un aspecto del neurodesarrollo y, como tal, su evolución puede ser óptima o quedar limitada en alguna de sus vertientes. Cuando esto ocurre, estamos ante un problema o trastorno del lenguaje (Albesa y Ayala, 2017). Los trastornos del lenguaje agrupan el conjunto de problemas que interfieren en la comunicación verbal a causa del desarrollo ineficiente de cualquier mecanismo implicado en el lenguaje, sin olvidar que la repercusión no se limita al intercambio de información, sino que también incide en el aprendizaje, el razonamiento, la interacción social, las emociones y la calidad de vida (Artigas-Pallarés et al., 2022).

En en edad infantil la situación es muy distinta. Los niños, como es obvio, pueden sufrir las mismas lesiones que el adulto, pero, aparte de ser menos frecuentes, inciden en un cerebro en fase evolutiva, lo cual condiciona diferencias respecto a los problemas del lenguaje del adulto.

En relación con ello, existen numerosos sistemas de clasificación en base a los distintos tipos de pensamiento de sus autores, siendo los más destacados el DSM-5 y la, actual, CIE-11. Ambos son dos sistemas clasificatorios ampliamente establecidos y utilizados en el ámbito internacional para el diagnóstico de los trastornos mentales de la edad adulta y también de la niñez y de la adolescencia:

En este sentido, y tomando como referencia las clasificaciones mencionadas, el estudio de los problemas del desarrollo del lenguaje topa con serios problemas epistemológicos derivados del uso canónico que imponen el *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) y la *International Classification of Diseases* (CIE). Si bien es cierto que ambos sistemas tienden a confluir, difieren en términos diagnósticos, clasificación y modelo diagnóstico, lo cual genera confusiones semánticas (Tabla 5).

Tabla 5. *Comparativa de los trastornos del lenguaje en la CIE-11 y el DSM-V (Delgado y Agudelo, 2021)*

DSM-5 (APA)	CIE-11 (OMS)
Trastorno del desarrollo neurológico	**Trastorno del neurodesarrollo**
Discapacidades intelectuales 1) Discapacidad intelectual. 2) Retraso general del desarrollo. 3) Discapacidad intelectual no especificada.	Trastornos del desarrollo intelectual 1) Trastorno del desarrollo intelectual. 2) Trastorno del desarrollo intelectual provisional. 3) Trastorno del desarrollo intelectual sin especificación.
Trastornos de la comunicación 1) Trastorno del lenguaje. 2) trastorno fonológico. 3) Trastorno de fluidez (tartamudez). 4) Trastorno de comunicación social (pragmático). 5) Trastorno de la comunicación no especificado.	Trastornos del desarrollo del habla o el lenguaje 1) Trastorno del desarrollo del sonido del habla. 2) Trastorno del desarrollo de la fluidez del habla. 3) Trastorno del desarrollo del lenguaje. 4) Otros trastornos especificados del desarrollo del habla o del lenguaje. 5) Trastorno del desarrollo del habla o del lenguaje sin especificación.
Trastorno del espectro del autismo	Trastorno del espectro autista
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad	Trastorno por hiperactividad con déficit de la atención
Trastorno específico del aprendizaje	Trastorno del desarrollo del aprendizaje
Trastornos motores 1) Trastorno del desarrollo de la coordinación. 2) Trastorno de movimientos estereotipados.	Trastornos del desarrollo de la coordinación motora
	Trastorno por movimiento estereotipados
Trastornos de tics 1) Trastorno de la Tourrete. 2) Trastorno de tics vocales motores o vocales persistentes. 3) Trastorno de tics transitorio. 4) Otro trastorno de tics especificado. 5) Trastorno de tics no especificado.	Tics o trastornos por tics primarios 1) Síndrome de Tourrette. 2) Trastorno por tic motor crónico. 3) Trastorno por tic fónico crónico. 4) Otros tics o trastornos por tics primarios especificados. 5) Tics o trastornos por tics primarios sin especificación.
	Síndrome secundario del neurodesarrollo
Otros trastornos del desarrollo neurológico 1) Otro trastorno del desarrollo neurológico especificado. 2) Trastorno del desarrollo neurológico no especificado.	Otros trastornos especificados del neurodesarrollo Trastornos del neurodesarrollo sin especificación

Se puede observar que, de forma general, ambos manuales guardan una línea similar en cuanto a la denominación de grupo y en algunos trastornos específicos. La discapacidad intelectual en el DSM-V el trastorno del desarrollo intelectual en la CIE-11 presentan características similares en su definición. Ambos manuales consideran el análisis a partir de la conducta adaptativa y consideran cuatro niveles de severidad (leve, moderado, grave y profundo).

Además, ambos coinciden en presencia de una condición para describir alteraciones cognitivas en niños menores de cuatro años, o cuando no se puede llevar a cabo una evaluación estandarizada (ceguera, sordera, problemas motores). Esta condición se denomina retraso general del desarrollo en el DSM-V o trastorno del desarrollo intelectual provisional en la CIE-11.

Sección 4.1 Equivalencias entre el DSM-V y la CIE-11

Ambas clasificaciones son el fruto de un trabajo riguroso llevado a cabo por profesionales de todo el mundo tratando de obtener un amplio consenso y, aunque no se duda de la compatibilidad de los códigos y de los términos, es cierto que existen diferencias.

Tabla 6.

Equivalencias entre DSM-V y la CIE-11

DSM-5	CIE-11
TRASTORNOS MENTALES	**MENTAL, BEHAVIOURAL OR NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS**
TRASTORNOS DEL DESARROLLO NEUROLÓGICO	**NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS (BlockL1-6A0)**
DISCAPACIDADES INTELECTUALES • Discapacidad intelectual – F70. Leve – F71. Moderado – F72. Grave – F73. Profundo • F88. Retraso general del desarrollo • F79. Discapacidad intelectual no especificada	**6A00 DISORDERS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT** • Disorder of intellectual development... – 6A00.0 ...mild – 6A00.1 ...moderate – 6A00.2 ...severe – 6A00.3 ...profound – 6A00.4 ...provisional • Disorders of intellectual development, unspecified
TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN • F80.2. Trastorno del lenguaje • F80.0. Trastorno fonológico • F80.81. Trastorno de fluidez (tartamudeo) de inicio en la infancia Nota: Los casos de inicio más tardío se diagnostican como trastorno de fluidez de inicio en el adulto (F98.5). • F80.89. Trastorno de la comunicación social (pragmático) • F80.9. Trastorno de la comunicación no especificado	**6A01 DEVELOPMENTAL SPEECH OR LANGUAGE DISORDERS** • 6A01.0 Developmental speech sound disorder • 6A01.1 Developmental speech fluency disorder • 6A01.2 Developmental language disorder – 6A01.20 ...with impairment of receptive and expressive language – 6A01.21 ...with impairment of mainly expressive language – 6A01.22 ...with impairment of mainly pragmatic language – 6A01.23 ...with other specified language impairment • 6A01.Y Other specified developmental speech or language disorders • 6A01.Z Developmental speech or language disorders, unspecified

TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO • F84.0. Trastorno del espectro del autismo – Especificar si: Asociado a una afección médica o genética, o a un factor ambiental conocidos; Asociado a otro trastorno del desarrollo neurológico, mental o del comportamiento – Especificar la gravedad actual de los Criterios A y de los Criterios B: Necesita ayuda muy notable, Necesita ayuda notable, Necesita ayuda – Especificar si: Con o sin déficit intelectual acompañante, Con o sin deterioro del lenguaje acompañante, Con catatonía (emplear el código adicional [F06.1])	**6A02 AUTISM SPECTRUM DISORDER** • 6A02.0 ...without disorder of intellectual development and with mild or no impairment of functional language • 6A02.1 ...with disorder of intellectual development and with mild or no impairment of functional language • 6A02.2 ...without disorder of intellectual development and with impaired functional language • 6A02.3 ...with disorder of intellectual development and with impaired functional language • 6A02.4 ...without disorder of intellectual development and with absence of functional language • 6A02.5 ...with disorder of intellectual development and with absence of functional language • 6A02.Y Other specified autism spectrum disorder • 6A02.Z Autism spectrum disorder, unspecified
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD • Trastorno por déficit de atención con hiperactividad – Especificar si: • F90.2. Presentación combinada • F90.0. Presentación predominante con falta de atención • F90.1. Presentación predominante hiperactiva/impulsiva – Especificar si: En remisión parcial – Especificar la gravedad actual: Leve, moderado, grave • F90.8. Otro trastorno por déficit de atención con hiperactividad especificado • F90.9. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado	**6A05 ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER** • 6A05.0 ...predominantly inattentive presentation • 6A05.1 ...predominantly hyperactive-impulsive presentation • 6A05.2 ...combined presentation • 6A05.Y Attention deficit hyperactivity disorder, other specified presentation • 6A05.Z Attention deficit hyperactivity disorder, presentation unspecified

TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE • Trastorno específico del aprendizaje – Especificar si: • F81.0. Con dificultad en la lectura (especificar si con corrección de la lectura de palabras, velocidad o fluidez de lectura, comprensión de la lectura) • F81.81. Con dificultad en la expresión escrita (especificar si con corrección ortográfica, corrección gramatical y de la puntuación, claridad u organización de la expression escrita) • F81.2. Con dificultad matemática (especificar si con sentido de los números, memorización de operaciones aritméticas, cálculo correcto o fluido, razonamiento matemático correcto) – Especificar la gravedad actual: Leve, moderado, grave	**6A03 DEVELOPMENTAL LEARNING DISORDER** • 6A03.0 ...with impairment in reading • 6A03.1 ...with impairment in written expression • 6A03.2 ...with impairment in mathematics • 6A03.3 ...with other specified impairment of learning • 6A03.Z Developmental learning disorder, unspecified
TRASTORNOS MOTORES • F82. Trastorno del desarrollo de la coordinación • F98.4. Trastorno de movimientos estereotipados – Especificar si: Con comportamiento autolesivo, Sin comportamiento autolesivo – Especificar si: Asociado a una afección médica o genética, trastorno del desarrollo neurológico o factor ambiental conocidos – Especificar la gravedad actual: Leve, moderado, grave	**6A04 DEVELOPMENTAL MOTOR COORDINATION DISORDER** **6A06 STEREOTYPED MOVEMENT DISORDER** • 6A06.0 ...without self-injury • 6A06.1 ...with self-injury • 6A06.Z Stereotyped movement disorder, unspecified
TRASTORNOS DE TICS • F95.2. Trastorno de la Tourette • F95.1. Trastorno de tics motores o vocales persistente (crónico) – Especificar si: Sólo con tics motores, Sólo con tics vocales • F95.0. Trastorno de tics transitorio • F95.8. Otro trastorno de tics especificado • F95.9. Trastorno de tics no especificado	**8A05 TIC DISORDERS*** • 8A05.0 Primary tics or tic disorders – 8A05.00 Tourette syndrome – 8A05.01 Chronic motor tic disorder – 8A05.02 Chronic phonic tic disorder – 8A05.03 Transient motor tics – 8A05.0Y Other specified primary tics or tic disorders – 8A05.0Z Primary tics or tic disorders, unspecified • 8A05.1 Secondary tics – 8A05.10 Infectious or postinfectious tics – 8A05.11 Tics associated with developmental disorders
	– 8A05.1Y Other specified secondary tics – 8A05.1Z Secondary tics, unspecified • 8A05.Y Other specified tic disorders • 8A05.Z Tic disorders, unspecified ***Los Trastornos de Tics o Tics Primarios son clasificados por la CIE-11 en el capítulo 8, Enfermedades del Sistema Nervioso, junto a los Tics Secundarios**
OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO NEUROLÓGICO • (F88). Otro trastorno del desarrollo neurológico especificado • (F89). Trastorno del desarrollo neurológico no especificado	**6A0Y Other specified neurodevelopmental disorders** **6A0Z Neurodevelopmental disorders, unspecified**

PSICOPATOLOGÍA DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE EN EL MARCO EDUCATIVO DE LA LOMLOE

El 29 de diciembre de 2020 se publicó el actual currículum educativo de España, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). Con su publicación, se incrementa la importancia de un planteamiento inclusivo en el currículo, fomentando el valor y respeto hacia la diversidad. Así, uno de los fines de la educación es el adecuarse a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.

Desde su entrada en vigor, se diferencian dos grandes grupos a ese respecto:

- Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)
- Necesidades Educativas Especiales (NEE)

Las NEAE son el grupo grande que engloba las necesidades, y las NEE es un grupo más pequeño que se refiere a necesidades asociadas a la discapacidad, y que están dentro de las NEAE.

La Institución educativa se configura como un sistema amplio y diverso que debe favorecer el desarrollo y la promoción de todos los alumnos, independientemente de sus características. No reconoce o trabaja con sujetos con discapacidad, sino que se abre a un nuevo concepto, alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

Se regirá por los principios de normalización e inclusión mediante un currículo abierto y flexible. Tiene como objetivo que los alumnos NEAE consigan la normalización e inclusión en el aula en los centros ordinarios (Ilustración 1).

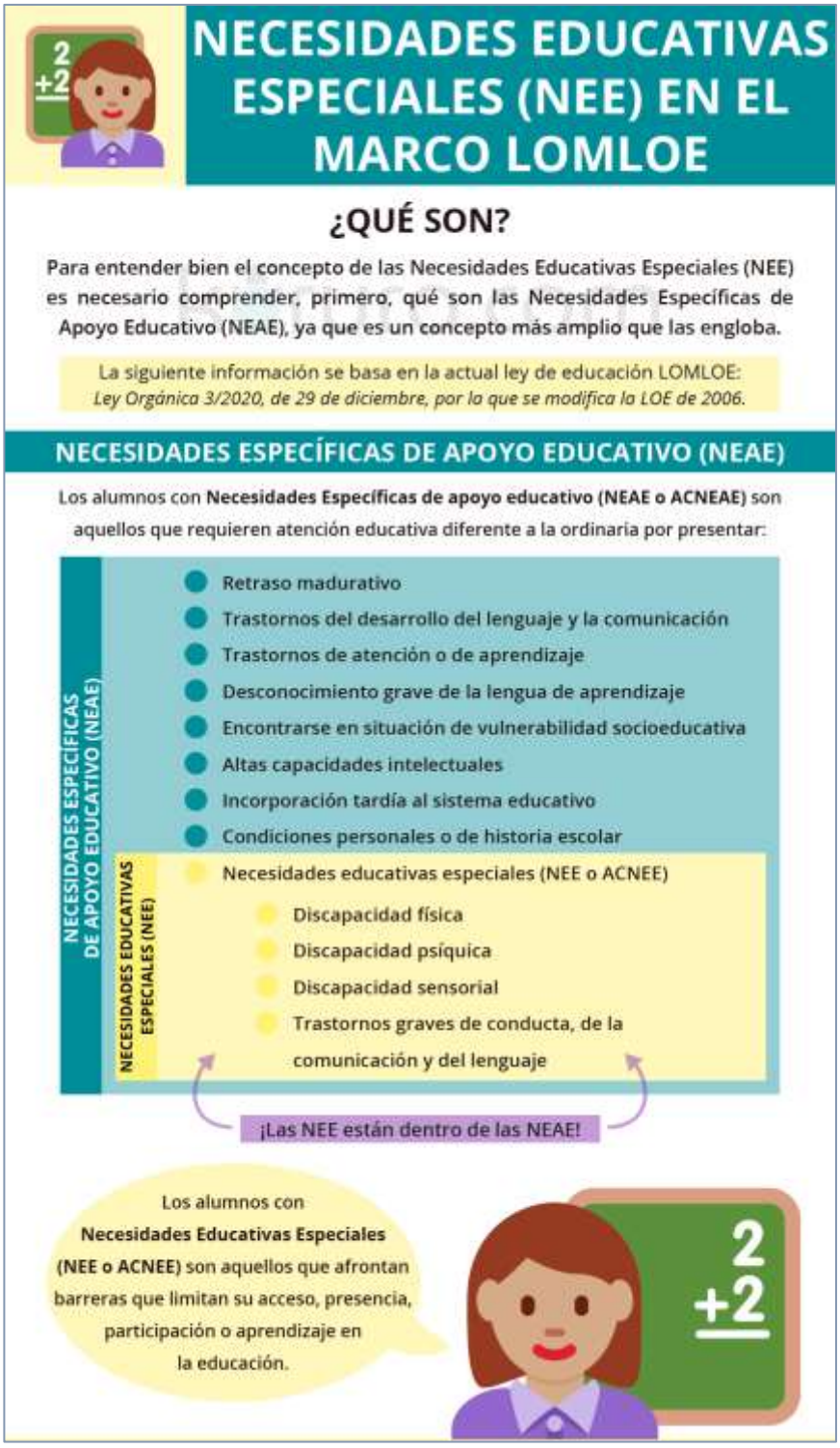


Ilustración 1. NEE y NEAE en el marco de la LOMLOE.

RESUMEN DEL TEMA

La psicopatología de la audición y el lenguaje estudia los trastornos y alteraciones que afectan a la voz, el habla, la comunicación, las funciones orofaciales y la audición. Estas alteraciones pueden comprometer uno o varios componentes del lenguaje: fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático, y estar influidas por factores biológicos, psicológicos y sociales.

Concepto de psicopatología y perspectiva infantil

La psicopatología tiene como finalidad describir, explicar y clasificar la conducta alterada, así como estudiar las variables relacionadas con ella para orientar la intervención. La psicopatología infantil se desarrolló posteriormente a la del adulto y continúa presentando dificultades de clasificación, debido especialmente a la influencia del desarrollo evolutivo, la edad, la elevada comorbilidad y la variabilidad de las manifestaciones clínicas. Por ello, una conducta debe valorarse siempre considerando el momento evolutivo y el contexto.

Las clasificaciones son importantes para la investigación, los estudios epidemiológicos y la evaluación de tratamientos, pero ningún sistema es completamente neutro ni recoge toda la complejidad de la psicopatología infantil. El profesional de Audición y Lenguaje debe equilibrar la objetividad y operatividad de los sistemas clasificatorios con una valoración flexible que tenga en cuenta la evolución individual.

Modelos de comprensión e intervención

La consideración de una conducta como típica o no típica depende de factores como su frecuencia, consecuencias, edad, desarrollo cognitivo, contexto y marco teórico. La psicología del desarrollo permite comprender los cambios biológicos, mentales y comportamentales a lo largo de la vida y analizar cómo los procesos adquiridos en una etapa influyen en los posteriores.

En Audición y Lenguaje destacan dos modelos complementarios:

- Modelo médico: analiza los aspectos biológicos y busca las causas del trastorno. Se organiza en sintomatología, etiología y etiopatogenia.

- Modelo conductual o educativo: analiza directamente la conducta lingüística alterada y sus características funcionales para orientar la intervención.

En la práctica educativa ambos modelos se complementan: el primero ayuda a conocer las características y necesidades del alumno y el segundo permite diseñar y desarrollar la intervención.

Análisis del lenguaje

La sintomatología describe las manifestaciones externas del trastorno, diferenciando síntomas y signos y considerando aspectos cuantitativos y cualitativos del lenguaje. La etiología estudia las causas, que pueden ser orgánicas, funcionales, orgánico-funcionales, endocrinas o ambientales. La etiopatogenia analiza el curso del trastorno y los factores que condicionaron su aparición, contribuyendo a establecer un pronóstico.

Desde el modelo educativo, el lenguaje se analiza en diferentes niveles: fonético (producción y percepción de sonidos), fonológico (organización de fonemas), morfológico-sintáctico

(estructura y combinación de palabras), contenido o semántico (significado y vocabulario) y uso o pragmático (función comunicativa, interacción, turnos, demandas y expresión emocional).

Clasificación de los trastornos

Los trastornos del lenguaje pueden repercutir no solo en la comunicación, sino también en el aprendizaje, razonamiento, interacción social, emociones y calidad de vida. Entre los principales sistemas de clasificación se encuentran el DSM-5 y la CIE-11. Ambos presentan numerosas correspondencias, aunque existen diferencias terminológicas y clasificatorias.

Psicopatología, educación e inclusión

La LOMLOE refuerza un planteamiento educativo basado en la inclusión y el respeto a la diversidad. Diferencia entre Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), categoría amplia, y Necesidades Educativas Especiales (NEE), relacionadas con determinadas discapacidades y trastornos. El sistema educativo debe favorecer la normalización e inclusión, mediante un currículo abierto y flexible y los apoyos necesarios.

Idea clave: el especialista en Audición y Lenguaje debe integrar conocimiento del desarrollo, lenguaje, logopedia y educación para realizar una valoración individualizada, evolutiva y contextualizada, identificando dificultades y fortalezas y transformando esta información en una respuesta educativa adecuada.

GLOSARIO

Audición: Función relacionada con la percepción de los sonidos y especialmente relevante para el desarrollo de la comunicación y el lenguaje.

Conducta alterada: Comportamiento que se diferencia de lo esperado y que puede generar consecuencias negativas para la persona o su entorno. Su valoración debe considerar edad, desarrollo y contexto.

CIE-11: Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Constituye uno de los principales sistemas internacionales de clasificación utilizados para los trastornos mentales y del neurodesarrollo.

Comorbilidad: Presencia simultánea de diferentes trastornos o dificultades en una misma persona. En población infantil presenta una elevada frecuencia y dificulta la delimitación de categorías diagnósticas.

DSM-5: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la American Psychiatric Association. Es uno de los principales sistemas internacionales de clasificación de los trastornos mentales y del neurodesarrollo.

Etiología: Estudio de las **causas** que provocan una determinada sintomatología o trastorno.

Etiopatogenia: Estudio del **curso y desarrollo del trastorno** y de los factores que condicionan su aparición. Contribuye a establecer el pronóstico.

Fonética: Nivel del lenguaje centrado en la producción y percepción de los sonidos mediante el funcionamiento del aparato fonador y las cavidades de resonancia.

Fonología: Nivel que estudia la selección y organización de los fonemas para configurar las palabras.

Funciones orofaciales: Funciones relacionadas con las estructuras orales y faciales implicadas, entre otros procesos, en el habla, la masticación y la deglución.

LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación. Refuerza la inclusión y la atención a la diversidad en el sistema educativo.

Modelo conductual o educativo: Modelo que analiza directamente la conducta lingüística alterada, comparándola con patrones de desarrollo esperados y utilizando la información obtenida para planificar la intervención.

Modelo médico: Modelo centrado en los aspectos biológicos del trastorno y en la búsqueda de sus causas. En Audición y Lenguaje contempla sintomatología, etiología y etiopatogenia.

Morfología: Dimensión relacionada con la estructura interna de las palabras y los elementos que las componen. En el documento se aborda junto con la sintaxis.

Morfosintaxis: Nivel que comprende la estructura interna de las palabras y las reglas mediante las cuales estas se combinan para construir oraciones con sentido.

NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo): Categoría amplia que engloba las diferentes necesidades específicas de apoyo que puede presentar el alumnado.

NEE (Necesidades Educativas Especiales): Necesidades educativas asociadas a determinadas situaciones de discapacidad o trastornos que requieren apoyos y atenciones educativas específicas. Constituyen un grupo dentro de las NEAE.

Nivel individual: Valoración de la capacidad comunicativa de una persona para desarrollarse y participar adecuadamente en los diferentes ámbitos de su vida.

Nivel social: Valoración de la capacidad de una persona para interactuar con otras y ajustarse al contexto y a las normas de interacción social.

Nivel temporal: Valoración de la evolución y duración de una dificultad o trastorno, considerando si es periódico, crónico, degenerativo, temporal o permanente, así como su origen y momento de aparición.

Pragmática: Dimensión relacionada con el uso funcional del lenguaje en diferentes contextos, incluyendo interacción, conversación, turnos, demandas, expresión emocional y regulación de la conducta.

Psicopatología: Disciplina científica dedicada al estudio, descripción, explicación y clasificación de las conductas alteradas y de las variables relacionadas con ellas.

Psicopatología infantil: Área de la psicopatología centrada en las alteraciones que aparecen durante la infancia y cuyo estudio requiere considerar especialmente el desarrollo evolutivo, la edad y el contexto.

Psicopatología de la audición y el lenguaje: Área que estudia los trastornos de la comunicación, el lenguaje, la voz, el habla, las funciones orofaciales y la audición.

Semántica: Dimensión relacionada con el significado de las palabras y con el vocabulario disponible para expresar pensamientos y sentimientos.

Signo: Manifestación observable, especialmente de carácter físico, asociada a una alteración o trastorno.

Síntoma: Manifestación subjetiva relacionada con una enfermedad o alteración. En el análisis del lenguaje se estudia junto con los signos y las características cuantitativas y cualitativas.

Sintomatología: Conjunto de manifestaciones externas que caracterizan una alteración o trastorno.

Sintaxis: Dimensión que estudia la combinación de palabras y la estructura de las oraciones mediante las reglas gramaticales.

Trastorno del lenguaje: Problema que interfiere en la comunicación verbal como consecuencia de un desarrollo ineficiente de alguno de los mecanismos implicados en el lenguaje. Puede repercutir también en aprendizaje, razonamiento, interacción social y emociones.

Uso del lenguaje: Aplicación funcional del lenguaje en función del contexto, el interlocutor y las necesidades comunicativas de la persona. Corresponde fundamentalmente al ámbito pragmático.

BIBLIOGRAFÍA

American Psychiatric Association., Kupfer, D. J., Regier, D. A., Arango López, C., Ayuso-Mateos, J. L., Vieta Pascual, E., y Bagney Lifante, A. (2013). *DSM-5: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5ª ed.)*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Albesa, S. A., y Ayala, C. O. (2017). Trastornos del lenguaje. *Pediatría integral*, *21*(1), 15.

Artigas-Pallarès, J., Pérez, I. P., y Mallofré, E. V. (2022). Trastornos del lenguaje. *Pediatría Integral*, *7*, 12.

Billard, C. (2014). Desarrollo y trastornos del lenguaje oral en la infancia. *EMC-Pediatría*, *49*(4), 1-11

Busto, M.C. (2008). *Manual de logopedia escolar*. Madrid: CEPE.

Casanova, J. (2006). *Manual de logopedia escolar.* Barcelona: Masson.

Delgado, A. C., y Agudelo, A. F. (2021). Trastornos del neurodesarrollo: una comparación entre el DSM-5 y la CIE-11.

Diéguez-Vide, F., y Peña-Casanova, J. (2012). Cerebro y lenguaje. *Sintomatología neurolingüística. Madrid: Editorial Médica Panamericana*.

Hernández-Pina, F. (1984). Actitudes lingüísticas parentales y desarrollo del lenguaje infantil. *Infancia y aprendizaje*, *7*(25), 35-59.

Marcelli, D. y Ajuriaguerra, J. (1996). *Manual de psicopatología del niño.* Barcelona: Elsevier Masson.

Mejías-Padilla, V. (2021). Implicaciones y Efectos Neurológicos en el Desarrollo del Lenguaje. *Revista Docentes 2.0*, *10*(1), 25-31..

Narbona, J., y Chevrie-Muller, C. (2001). *El lenguaje en el niño: desarrollo normal, evaluación y trastornos*. Barcelona: Masson.

Navarro-Pablo, M. (2003). Adquisición del lenguaje. El principio de la comunicación. *Cauce, 26, 321-347.*

Sánchez, M. P., Ortuño Ibáñez, A., y Belda Galbis, A. C. (2015). De la atención de los problemas de la audición y lenguaje a la logopedia como disciplina. *Revista Iberoamericana de Educación, 2015, vol. 67, num. 1, p. 169-186*.

Vives Gomila, M. (2008). *Psicodiagnóstico clínico infantil*. Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona.